



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ناهد رشدي عبده سالم

العنوان : ** - *

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 26706252101541 رقم التليفون : 01125341394 تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-06-1967 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ناهد رشدي عبده سالم National ID: 26706252101541	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ناهدا

رشدي عبده سالم

قرية ابوالنمرس

مركز ابوالنمرس - الجيزة

١٩٦٧/٠٦/٢٥

٢٦٧.٦٢٥٢١.١٥٤١

JP8915816



٢٠٢٢/١١

٢٦٧.٦٢٥٢١.١٥٤١

ربة منزل



متروجة

مستغنية

أنفى

جمعه حماده سيد محفوظ

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٠١



٥٦٧-٦٥٥١٠٥٤١



مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

18/ 8 / 2025 G

Name	ناهد سعيدة محمد	MRN	١٩٩/٢٥٥
Age	57	ID	
Menopausal status	M.	Phone	٠١٠ ١١٦٦٢٨١
NRS SCORE		Marital status	M.
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	D.M	REASON OF MDT	Post-op

Clinical Data

BX: I.D.C GLE Fxal DCIS

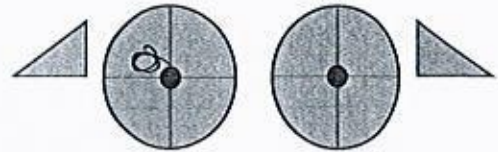
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	5/8	0	3%

Sonomammography:

Mets Workup:

Post up front SM and SNLB.
Invasive lobular carcinoma Grade II
with lobular Carcinization.

R



MDT

Initially

L

TNM

Recommendations:

Free deep margins
Free SNLB (o/4)
Stage PT2, PNo.

MDT OUTCOME & PLAN

In view of Mastectomy → No PRT
Rx: Adx AI x 5-7 years
Zouta / 6mt.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: ناهد رشدي عبده سالم		
MR. : 4746		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The multidisciplinary team discussion in August 2025 reviewed the patient’s postoperative status after upfront surgery for a stage T2 N0/4 breast carcinoma. The plan was to proceed with adjuvant aromatase inhibitor therapy combined with zoledronic acid (Zometa) for bone health. On 15 January 2026, the patient was started on Femara 2.5 mg daily. The most recent oncology note indicates that the patient continues on zoledronic acid (Zometa) and Femara for metastatic breast cancer involving the chest, with reported pain in the ribs and scapula. The current plan is to manage the skeletal pain and continue the ongoing endocrine and bone-targeted therapy.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	
	نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name	: الأستاذة / ناهد رشدي عبده سالم	Request No.	: 13005829
Patient No.	: 26706252101541	Request Date	: 26/02/2025
Path No.	: 854/25	Verification Date	: 16/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 57 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 26/2/2024, 9:10 am.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Carcinoma in situ component: Focal LCIS.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8 /8).
 - PR: Moderate nuclear reaction in 25% of tumor cells (score 5 /8).
 - Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
 - Ki67: 3% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive lobular carcinoma G II with focal LCIS.

IPT:

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 5 /8).

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 25/03/2025 10:39:48

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / ناهد رشدي عبده سالم	Request No. : 13005829
Patient No. : 26706252101541	Request Date : 26/02/2025
Path No. : 854/25	Verification Date : 16/03/2025
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 57 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 3% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 25/03/2025 10:39:48

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذ / ناهد رشدي عبده سالم	Request No.	: 13009330
Patient No.	: 26706252101541	Request Date	: 02/08/2025
Path No.	: 2422/25	Verification Date	: 07/08/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Dr.Heba Hasan

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer (Up-Front).

Nature of the specimen:

Right SM & right SLN biopsy

Gross Examination:

- Procedure: Right simple mastectomy specimen measured 24x20x6 cm with covering skin ellipse measured 17x10 cm .
- Tumor extent : A greyish white granular tumour bed site
- Size: 4x2.5x2 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: Fibrofatty tissue piece measured 4 x3 x1 cm enclosing 4 SLNs up to 1.5 x0.5 cm .

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive lobular carcinoma with lobular cancerization .
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis):
Grade 2 (3+2+1)
- Angioinvasion: Absent .
- Ductal carcinoma in situ: Absent
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/4)
- Resection Margins: Free deep margin

Diagnosis:

Right Simple Mastectomy & right SLN biopsy (Up-Front):

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Patient Name	: الأستاذة / ناهد رشدي عيده سالم	Request No.	: 13009330
Patient No.	: 26706252101541	Request Date	: 02/08/2025
Path No.	: 2422/25	Verification Date	: 07/08/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوسفاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Dr.Heba Hasan

Pathology Report

Invasive lobular carcinoma grade 2 with lobual cancerization .

- Free deep margin
- Free nipple and areola
- Free SLNs (0/4)
- Stage : pT2 , pN0

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr.Menan Hosam

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

Printing Date : 14/08/2025 09:32:54

Page 2 of 2



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Women's Health Outreach Program

Name: Nahed Roshdy Abdo

Date: 23/2/2025

Bilateral Full Field Digital Mammography

Indication: Right breast lump.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views: High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Heterogeneously dense breast parenchyma (ACR c)
- No masses, or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound: Right breast UOQ 11/12 o'clock para-areolar region shows heterogeneous hypoechoic distorted parenchyma, measuring about 3x2.5 cm with internal vascularity detected by Color Doppler.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- No pathological axillary lymph nodes detected.

Left breast

- Heterogeneously dense breast parenchyma (ACR c)
- No masses, asymmetry, distortion or suspicious clusters of microcalcifications. Benign calcifications.
- Ultrasound: No solid or cystic lesion
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary lymph nodes detected.

Impression:

- Right breast: 11/12 o'clock para-areolar palpable distorted parenchyma (BIRADS 4b) For US guided core biopsy and histopathological correlation.
- Left breast: Benign calcifications (BIRADS 2)

Dr. Ghada Khaled, MSc



Patient Name: Nahed Roshdy Abdou	Date : 26/04/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 1049/2025	Pat. ID: 99137

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of right breast cancer.

I Chest:

- Right breast heterogenous parenchyma with prominent ipsilateral axillary lymph nodes.
- Right fissural calcified pulmonary nodule .
- No sizable pulmonary nodules, masses, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys, suprarenal glands, aorta and IVC.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- Fat containing umbilical hernia
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

Reported case of right breast cancer revealed:

- No CT evidence of sizable pulmonary or hepatic deposits

Prof. Menna Talla Hanafy, M.D.